猫咪腹泻 · 深度科普与解决大全

基于权威兽医信源的系统指南 + 多多（6月龄·公·狸花猫）专属排查与调整方案

版本 v1 | 生成日期 2026-10-15 | 字数约 1.2 万 | 含 7 张图表 | 阅读时长约 25 分钟

目录

Part A 知识大科普
A1 什么是腹泻（含粪便评分图）
A2 四大病理机制（图解）
A3 急性/慢性 + 小肠/大肠鉴别
A4 常见病因谱（排名图）
A5 年龄分层：幼/青/老
A6 急诊红线：何时必须就医
Part B 解决方法大全
B1 标准化排查路径（决策树）
B2 饮食调整：原料与理论
B3 水分管理
B4 过渡换粮法（7/14日）
B5 益生菌 / 益生元
B6 常用药物机理与红线
B7 居家护理与记录表
Part C 多多专属方案
C1 个案时间线复盘
C2 研判（事实/推断/建议）
C3 14天调整计划
C4 一页式快速排查卡
参考文献与来源

Part A · 知识大科普

A1 什么是腹泻

定义：腹泻是粪便性状变稀、排便次数或总量多于正常，本质是"肠内容物通过过快 + 水分/电解质吸收减少"。VCA Animal Hospitals 明确指出：**腹泻本身不是疾病，而是众多疾病的共同症状**；即使由轻症引起，若不及时处理也可能因脱水等变得严重（VCA Animal Hospitals, "Diarrhea in Cats"）。

健康猫的粪便应为**成形、分节、捡起不散**。判断是否腹泻，看三件事：**形态（软/糊/水）、频率（是否明显增多）、是否带血/黏液**。若频繁液状或半液状粪便**持续超过 2 天**，应咨询兽医（VCA）。

图1 • 粪便性状评分谱（1–7 级，猫用改编版）



健康区间偏软 软便腹泻严重腹泻 猫的理想粪便约在 2–3 级；4 级起属"软便"，5–7 级属腹泻。居家每天铲砂看一眼即可自评。

评分方法（居家可用）：每天记录便便落在哪一级、次数、颜色、是否带血/黏液。连续 3 天 ≥5 级即算"腹泻在活动"，应进入 Part B 排查流程。

A2 腹泻的四大病理机制（为什么"拉稀"）

无论病因是什么，腹泻最终都通过以下四类机制之一（或组合）发生（catmd.ca, "Diarrhea"）：

① 渗透性	② 分泌性	③ 渗出性	④ 动力性
Osmotic	Secretory	Exudative	Motility
未消化溶质 把水"拉"进肠腔	肠壁主动 "吐"出水/电解质	肠黏膜破损 漏血/蛋白/脓液	蠕动过快 来不及吸水
例:吃多/ 不耐某成分	例:细菌毒素/ 炎症(IBD)	例:寄生虫/ 细菌感染/溃疡	例:应激/ 肠易激

真实病例常为多种机制叠加；偷吃变质虾头即"渗透+分泌+渗出"三联击。

理论要点：**渗透性腹泻在禁食/减量后会明显减轻**（因为少了"未消化溶质"）；**分泌性/渗出性腹泻禁食也难停**，往往提示感染或炎症，需要就医。这条规律是居家判断"能不能先观察"的关键。

A3 急性/慢性之分 + 小肠/大肠鉴别

急慢性：腹泻 **≤2–3 周**多为急性（食物、寄生虫、感染、应激）；**持续 >3 周，或一个月内间歇性反复**即归为慢性（Expert Cat Care；SpectrumCare, "Chronic Diarrhea in Cats"）。慢性不等于严重，但意味着需要系统排查，而非仅靠禁食。

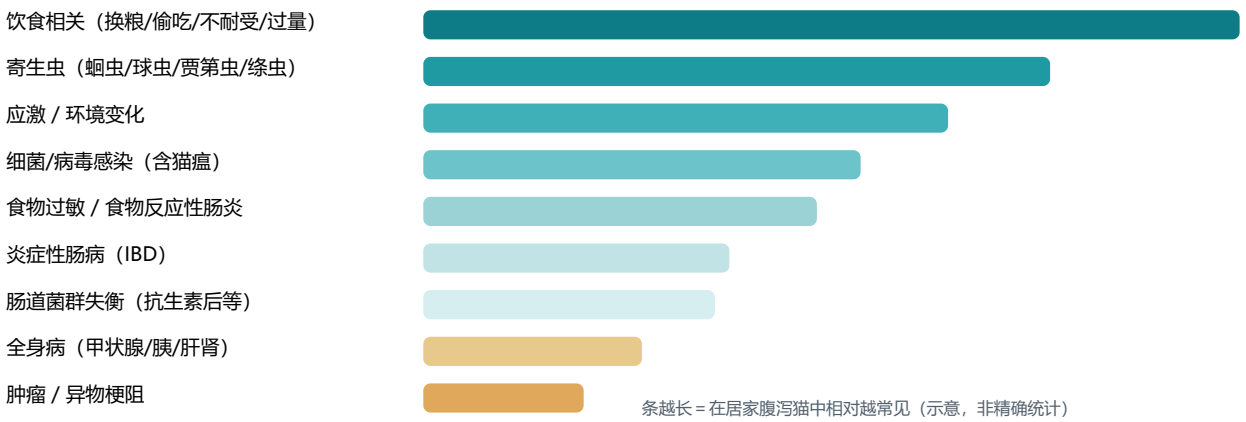
定位（小肠 vs 大肠）是兽医缩小病因范围的第一步。看大便"长什么样"就能初判（Small Animal Internal Medicine, 教科书 Table 11-1；Expert Cat Care）：

特征	小肠性腹泻（Small bowel）	大肠性腹泻（Large bowel / 结肠）
排便量	正常或增多	减少（每次少量）
排便频率	正常或轻度增多	明显增多（频繁跑砂盆）
黏液	通常无	常有（果冻状）
血	若有→黑便/柏油样（消化过）	常有鲜红血（hematochezia）
里急后重/努责	无	常有
呕吐	可能出现	可能出现
体重下降	**常见**	少见
典型病因	食物不耐受、IBD、寄生虫(蛔虫/绦虫)、胰/甲状腺/肝肾等全身病	结肠炎、应激、球虫/贾第虫、部分食物过敏、直肠异物

> 多多个案提示：**间歇性软便、精神食欲好、无血无黏液无消瘦**——更接近"轻度、以饮食/菌群相关为主"的模式，倾向于大肠性或轻度小肠性，暂未指向严重全身病。但仍需按慢性流程管理（见 Part C）。

A4 常见病因谱（相对常见度，示意排名）

下图按"在居家猫中出现的大致相对频率"排序，**仅供优先级参考，非流行病学精确比例。**注意：小猫（如多多）感染性/饮食性占比更高。



A5 年龄分层：幼猫 / 青年猫 / 老年猫

年龄段	更常见病因	特别提醒
幼猫（<6月，如多多）	寄生虫、感染、换粮/偷吃、先天性消化弱、低血糖风险	免疫系统未成熟；**禁食耐受差，小猫别长时间断食**；脱水更快
青年/中年（1–7岁）	食物过敏（食物反应性肠病）、IBD、应激、异物	慢性病开始显现，需做食物排查试验
老年（>7岁）	慢性肾病、甲亢、肠癌、慢性胰炎、EPI	"吃多还瘦+一直拉"要查甲功/肾/胰

A6 急诊红线：何时必须就医

出现以下任一，不要在家硬扛，尽快就医：

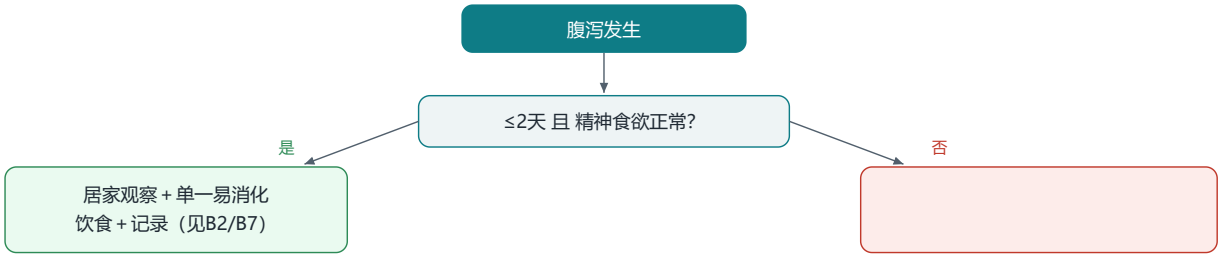
- **血便**（鲜红或黑柏油样）或大量黏液
- **呕吐**（尤其频繁、带黄绿胆汁、带血）
- **精神沉郁**：嗜睡、躲藏、反应迟钝、不爱动
- **脱水**：提起颈后皮肤回弹慢、牙龈干、眼窝凹陷
- **体重下降 / 消瘦**、食欲明显减退或拒食
- 腹泻 **持续 >2 天无改善**，或 **反复发作超 3 周**
- 疑似**吃了异物 / 有毒物**（葱蒜、葡萄、巧克力、药）
- **小猫（<6月）腹泻伴精神差**——风险高于成年猫

来源：VCA Animal Hospitals；SpectrumCare；猫后苑（HK）。

Part B • 解决方法大全

B1 标准化排查路径（决策树）

把"看到腹泻→该做什么"固化成一条可执行的链路。下图为总览，文字步骤紧随其后。



有警示信号? 血/吐/沉郁/脱水/消瘦 **立即就医（急诊）** 大便特征定位? 小肠型大肠型 查全身病：血检/甲功/胰/腹腔超声/B12叶酸（量大·消瘦·呕吐） 粪检(注意假阴性)＋食物排查试验2–4周（频繁·黏液·鲜血） 仍无效 → 粪PCR / 肠镜活检 / 专科 注：粪检有"假阴性"（虫卵非每次排出），必要时复查或做PCR

居家可执行步骤（精神好、无警示信号时）：

1. **记录**：便便分级、次数、颜色、血/黏液、进食量、精神状态（用 Part B7 表格）。
2. **暂停"可疑新东西"**：停零食、停新粮、停一切人食；回到"已知不拉"的饮食。
3. **单一易消化餐**：见 B2 居家温和餐；少食多餐（多多尤要）。
4. **补水**：多放水碗/流动水/肉汤（无盐无葱蒜），见 B3。
5. **观察 24–48 小时**：若升级为警示信号→就医；若好转→维持并缓慢过渡。
6. **若 >2 天无改善或反复**：带"当天新鲜粪便样本"就医，进入专业排查（B1 树）。

B2 饮食调整：原料与理论（不推品牌，只讲该有什么、为什么）

用户要求：**不推荐具体品牌商品**，只说明主要原料需要什么、理论依据是什么。以下按"原料 → 理论支撑 → 日常哪里买得到"展开。

原料（日常可购）	理论支持	怎么用
鸡胸肉（超市/菜场，蒸熟，去皮去脂）	高消化率**动物蛋白**、低抗原性、低脂。未消化蛋白若进入结肠会被细菌发酵→产气+渗透压↑→稀便；易消化的优质蛋白减少"漏网溶质"。放射科诊所等建议腹泻期用"高消化蛋白+低脂肪"配方（Radiokop Vet）。	蒸熟撕碎，做主食基底；占餐量主体
南瓜（菜场，蒸熟打成泥，**无任何添加**）	含**可溶性+不可溶性纤维。**可溶性纤维在肠腔内吸水成凝胶→固化稀便、减慢 transit；其发酵产生**短链脂肪酸(SCFAs)**为结肠细胞供能、养有益菌（prebiotic）。多个兽医科普一致推荐（Biology Insights；CatSphere；ScienceInsights）。	成猫 ½–1 茶匙/餐拌入；**多多（幼猫）从 ¼ 茶匙起**，渐增；用 100% 纯南瓜，忌南瓜派馅（含肉豆蔻/木糖醇，对猫有毒）
白米饭 / 米汤（少量）	低敏、易消化碳水，提供能量且略有"收敛"作用，是经典 bland diet 组分。猫非必需碳水，**仅恢复期少量**作粘合/能量，不宜长期主食。	煮软，混合鸡胸肉泥；占小比例
熟鸡蛋黄（蒸熟，适量）	含卵磷脂、维生素与易吸收营养；**熟**制可避免生蛋清中抗生物素蛋白(avidin)干扰。注意：不过量、确认不过敏。	隔天半个蛋黄拌入；观察便便
凉白开 / 无盐无葱蒜肉汤	腹泻丢水丢电解质；猫天生渴感弱、吃干粮更易缺水。增加液体摄入预防脱水、软化 transit（VCA：腹泻猫必须保证饮水）。	多置水碗 + 流动水；肉汤每日少量
益生菌（含特定菌株，见 B5）	菌株特异性地恢复菌群、竞争病原、产 SCFAs、提升肠道 IgA。	按说明拌入；水温≤40℃ 以免杀活菌
洋车前子壳粉（可溶性纤维，极少量）	高纯度可溶性纤维，大肠性腹泻时在肠腔形成凝胶固化粪便；需充分泡发。**用量需兽医指导**，过量反致胀/泻。	极少量（牙签尖）泡水后拌入；非必需

居家"温和餐"参考配方（腹泻活动期 / 过渡期）

组成：蒸熟鸡胸肉（去脂）70% + 熟南瓜泥 20% + 软米饭/米汤 10% + 少许无盐肉汤调湿度。每日分 3–4 餐、每餐少量（契合多多"吃多就拉"的体质）。

理论：高消化动物蛋白（少渗漏溶质）+可溶性纤维（吸水固化）+低脂肪（减轻消化负担）+少量易消化碳水（能量）+少食多餐（降低每餐渗透压负荷）。待便便回到 2–3 级稳定 3–5 天后，再按 B4 缓慢过渡到常态饮食。

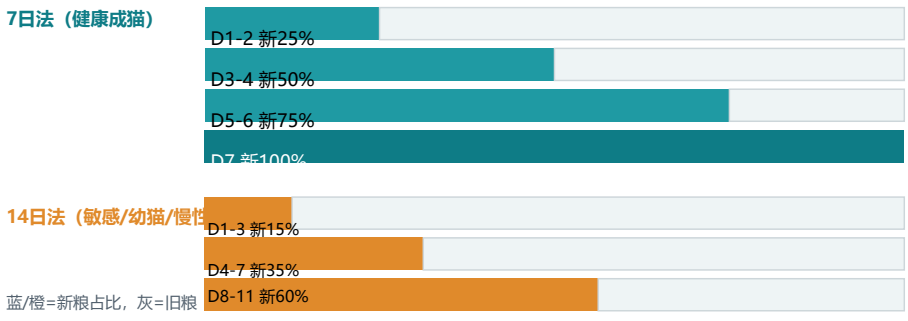
> **绝对避免：**高盐/调味人食、生肉生鱼、虾壳虾头、牛奶（猫乳糖不耐）、高脂、葱蒜（溶血）、葡萄/巧克力、突然换粮、多种零食轮换、人用止泻药（多数对猫有毒，须兽医处方）。

B3 水分管理

- **为什么重要**：猫祖先来自干旱环境，渴感弱；吃干粮猫普遍慢性缺水。腹泻时水分从肠道大量丢失，**脱水是幼猫最危险的并发症。**
- **怎么做**：家中≥2 个水碗分散放置；用流动饮水机提升兴趣；湿粮/肉汤提升摄入；腹泻期可少量多次补电解质（兽用口服补液盐，遵医嘱）。
- **自测脱水**：提颈后皮肤，松手后 1 秒内回弹为正常；回弹慢、牙龈干、眼窝凹 = 脱水，就医。

B4 过渡换粮法（7 日 / 14 日）

猫肠道菌群对旧粮配方有"记忆"，骤换→菌群来不及适配→渗透压失衡/发酵→软便。权威营养学会与多篇兽医科普均推荐**渐进换粮**；肠胃敏感/幼猫/慢性肠病者拉长到 **10–14 天**（台湾宠物营养保健食品学会；东北网引《2026中国宠物行业白皮书》；氧宠博士）。



> **便便是推进依据，不是日历：**出现软便→停在当前比例稳住 2–3 天；加重→退回上一档甚至回旧粮；一切正常才进下一档。敏感猫实际常需 10–14 天，慢不是失败。

B5 益生菌 / 益生元

事实层（有研究支持）

猫咪腹泻相关益生菌证据最强的是

特定菌株

：*Enterococcus faecium* SF68。随机对照试验显示，服 SF68 的猫腹泻评分显著低于安慰剂组（P=0.0058，PubMed 29291771, 2017）；该菌株在收容所猫、慢性非特异性腹泻猫、幼猫中均被证实可改善粪便质量/预防腹泻（Purina FortiFlora 资料；AAFP 会议综述）。*Saccharomyces boulardii*（布拉氏酵母）在人或犬猫腹泻中亦有应用（氧宠博士提及）。

推断层

多多属"菌群偏弱 + 急性炎症后未完全恢复"，补充

有研究背书、标明菌株与活菌数

的益生菌，理论上有助于菌群重建与肠黏膜修复，但属于辅助而非治疗根本病因。

建议层

选购时认"菌株名 + 活菌数 CFU + 有临床研究/兽医推荐"，不迷信"含益生菌"泛称；AAFP 综述提醒部分产品

实际活菌不达标

，质量参差。拌入食物、水温≤40℃。

B6 常用药物机理与红线

类别	机理	居家红线
蒙脱石类（吸附剂）	物理吸附毒素/水分、保护黏膜	需兽医指导用量；与益生菌/药隔开 2h 服，否则互相吸附失效
益生菌（见 B5）	恢复菌群、竞争病原	选对菌株；非万能，无效要查因
抗生素（如甲硝唑）	杀厌氧病原/抗炎（IBD）	**必须兽医处方**；滥用伤菌群；幼猫剂量敏感
驱虫药	清除寄生虫	即便粪检阴性，慢性软便兽医常仍建议"经验性驱虫"；按体重给药
人用止泻药	—	**多数对猫有毒（如洛哌丁胺可致中枢抑制），严禁自用**

> **红线总结：**任何人用止泻/抗菌药都不要给猫自行使用；药物仅限兽医处方。居家能做的=饮食管理 + 补水 + 记录 + 益生菌辅助。

B7 居家护理与记录表

记录是给兽医最有价值的素材。建议连续记 2 周：

日期	便便分级(1-7)	次数	颜色/血/黏液	当日饮食	精神/食欲	备注
—						
—						
—						

> 同时每周称一次体重（幼猫用厨房秤），毛色/体重是比便便更客观的"长期健康指标"。多多"发黄"建议同步观察体重与营养摄入。

Part C · 多多专属方案

C1 个案时间线复盘

时间	事件	解读
幼年期	很饿→暴食→软便；减量后正常才打疫苗	先天/喂养不规律致肠道耐受力偏弱，"吃多就拉"体质
约 1 个月前	打第 2 针疫苗；同期偷吃垃圾桶虾头	疫苗轻微应激 + 虾头诱因叠加
此后 ~1 个月	持续腹泻（间歇性软便，吃错就犯）	急性肠炎后未完全平复，或转为食物反应性/慢性
近期	就医 + 粪检无异常 + 已驱虫；精神好、活蹦乱跳	基本排除寄生虫/传染病；非紧急，但已超慢性阈值(>3周)
当前	定时定量三餐、每顿不多、日总量 <40g、商品干粮	喂食管理良好；但总量偏少，可能营养/水分不足（或关联毛色发黄）

C2 研判（事实 / 推断 / 建议 三层）

事实层（已确认）

①公猫约6月；②间歇性软便1月余、精神食欲正常；③粪检无异常、已驱虫；④定时定量三餐、日粮 <40g、商品干粮；⑤幼期"吃多就拉"史；⑥偷吃变质虾头诱因。

推断层

①寄生虫/传染病基本可排除；②核心为"幼期敏感肠 + 虾头诱发的急性炎症未愈/食物反应性"；③长期偏低喂食可能营养与水分摄入不足，或间接关联毛色偏黄；④干粮低水分不利敏感肠恢复。

建议层

①维持定时定量、

不盲目再减量

，改为"少食多餐＋提升消化友好度"；②以 B2 温和餐为过渡（不必全换，可先拌入）；③补足水分；④补有研究背书的益生菌；⑤记录 2 周；⑥若 >2 周仍反复或出现异常→带新鲜粪便复查（粪 PCR/B12/食物试验）。

C3 多多的 14 天调整计划（示例）

阶段	做法	目标
第1–3天	维持现干粮量，每餐拌入：熟鸡胸肉泥(少量)＋¼茶匙南瓜泥＋几勺无盐肉汤；益生菌按说明；暂停一切零食	不骤减、降低每餐渗透压、补纤维与水
第4–7天	温和餐比例升至每餐 30–40%；南瓜可到 ½ 茶匙；观察便便回到 3–4 级	便便成形、稳定
第8–11天	若便便稳，温和餐占 50–60%，其余为原干粮（按 B4 慢过渡逻辑）	逐步衔接常态饮食而不刺激
第12–14天	评估：稳→维持并缓慢回到正常总量(参考6月猫干粮约50–70g/日，分3–4餐)；不稳→就医做食物试验/粪PCR	建立长期可维持方案

关于"日总量 <40g"：6 月龄、约 2–3kg 的猫，干粮日需参考约 50–70g。多多目前偏少，可能"为了求不拉而喂太少"。正确方向不是再减，而是在**不撑着**的前提下，用易消化高蛋白＋纤维＋少食多餐把总量稳回合理区间，同时观察体重与毛色。

C4 一页式快速排查卡（可打印）

多多•腹泻快速排查卡

身份：公猫·约6月·狸花猫（疑彩狸/黄狸）·日粮<40g·商品干粮·定时三餐

当前状态：间歇性软便1月＋、精神好、粪检阴性、已驱虫、无血/无吐/无消瘦

---

① **每天做：**铲砂看便便分级(目标2–3级)＋记饮食＋称水碗；每周称体重。

② **饮食：**定时定量→**改少食多餐**；每餐拌熟鸡胸泥+¼–½茶匙纯南瓜泥+无盐肉汤；停零食/人食/虾；不盲目再减量。

③ **补水：**多水碗＋流动水＋肉汤，防脱水。

④ **益生菌：**选"标明菌株(如E. faecium SF68)+活菌数"的产品，≤40℃拌入。

⑤ **立刻就医（任一）：**血便/黑便、呕吐、沉郁、脱水(提皮回弹慢)、消瘦拒食、>2天无改善或反复超3周。

⑥ **复查时点：**按本卡执行 2 周仍反复→带**当天新鲜粪便**就医，查粪PCR/B12叶酸/食物排查试验。

注：本卡为居家管理备忘，不替代兽医诊断。毛色偏黄建议同步关注体重与营养摄入，必要时体检。

参考文献与来源

- VCA Animal Hospitals. *Diarrhea in Cats*（定义/病因/严重性/诊断/治疗/预后）. 访问 2026-10-15.
- catmd.ca. *Diarrhea in Cats*（病理生理分类：渗透/分泌/渗出/动力；小肠vs大肠鉴别；病因）. 访问 2026-10-15.
- Expert Cat Care. *Why Does My Cat Have Diarrhea? Investigations & Treatment*（急慢性定义、小肠/大肠表、年龄分层）. 访问 2026-10-15.
- SpectrumCare. *Chronic Diarrhea in Cats*（慢性≥3周或一月内反复；检查路径；警示信号）. 访问 2026-10-15.
- Small Animal Internal Medicine（教科书 PMC7151799）. Table 11-1 小肠 vs 大肠腹泻鉴别. 访问 2026-10-15.
- Torres-Henderson C, et al. *Effect of Enterococcus faecium SF68 on GI Signs and Fecal Microbiome in Cats Administered Amoxicillin-Clavulanate.* Top Companion Anim Med. 2017;32(3):104-108. PMID: 29291771（RCT，P=0.0058）.
- Purina Pro Plan Veterinary Diets. *Feline FortiFlora* 产品资料（SF68 对慢性腹泻/幼猫腹泻证据）.
- AAFP（catvets.com）会议综述. *Probiotics in cats*（证据最强于GI综合征；产品质量参差）. 访问 2026-10-15.
- Biology Insights / CatSphere / ScienceInsights / PetsCare. *Pumpkin for cats diarrhea*（可溶性纤维机理、剂量、忌南瓜派馅）. 访问 2026-10-15.
- 氧宠博士（isdpp.com）. *猫咪"玻璃胃"怎么调理 / 经常软便怎么调理*（定时定量、慢换粮、优质动物蛋白、益生菌）. 访问 2026-10-15.
- 宠搜网（chongso.com）. *猫咪软便原因与调理 / 7天换粮法*. 访问 2026-10-15.
- 台湾宠物营养保健食品学会. *七天渐进去粮法之科学实践与临床指引*（菌群记忆、敏感猫延长10–14天）. 访问 2026-10-15.
- 东北网. *《2026中国宠物行业白皮书》喂养行为调研*（>62%宠主换粮、约四成换粮后软便）. 访问 2026-10-15.
- 猫后苑（catgarden.app, HK）. *猫咪拉肚子原因与就医判断*（7日换粮、寄生虫假阴性、便色判读、慢性>2–3周就医）. 访问 2026-10-15.
- 虾/海鲜风险多篇（ouyi89、ouyi81、dongwangask、baidu健康）. *猫吃虾风险*（虾壳几丁质难消化/梗阻、虾头组胺、高钠、生虾细菌、过敏、零食≤10%热量）. 访问 2026-10-15.
- Radiokop Animal Clinic. *Chronic diarrhoea in dogs and cats*（高消化蛋白+低脂肪 bland diet；益生菌）. 访问 2026-10-15.

免责声明：本文为科普与居家管理参考，内容综合自上述公开权威信源并标注，**不能替代执业兽医诊断与治疗。**如症状加重或出现警示信号，请立即就医。

文档版本 v1 ｜ 生成 2026-10-15 ｜ 作者：爱莉（WorkBuddy 执行型协作者） ｜ 同步：ima 中转区 + QQ邮箱 (jaeyeonn@qq.com)